

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
Департамента лекарственных
средств и медицинских изделий при
Министерстве здравоохранения
Кыргызской Республики
Кысанов Т.А. 
« 14 » января 2025 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

СЕНУРИКС ДУО

Торговое наименование
Сенурикс Дуо

Международное непатентованное или группировочное наименование
Солифенацин + Тамсулозин

Лекарственная форма, дозировка
Таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые плёночной оболочкой
6мг/0,4мг.

Состав лекарственного препарата

Одна таблетка содержит

активные вещества: солифенацина сукцинат 6 мг, тамсулозина гидрохлорид 0,4 мг,

вспомогательные вещества:

Слой тамсулозина гидрохлорида

Целлюлоза микрокристаллическая, полиэтиленоксид 7 000 000, магния стеарат.

Слой солифенацина сукцината

Целлюлоза микрокристаллическая, кальция гидрофосфат, кремний коллоидный безводный, натрия кроскармеллоза, железа оксид красный (Е 172), магния стеарат.

Оболочка

Опадрай® 03F250016 красный: гипромеллоза, железа оксид красный (Е 172), макрогол, титана диоксид (Е 171).

Описание

Круглой формы двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой красного цвета (около 9 мм), с надписью "T7S" на одной стороне и гладкие с другой.

Фармакотерапевтическая группа

Мочеполовая система и половые гормоны. Урологические препараты. Препараты для лечения доброкачественной гипертрофии простаты. Альфа-адреноблокаторы. Тамсулозин и солифенацин.

Код АТХ: G04CA53

Фармакологические свойства

Фармакологическое действие

Комбинированное лекарственное средство, содержащее два активных вещества, солифенацин и тамсулозин. Данные активные вещества имеют независимые и взаимодополняющие механизмы действия при лечении симптомов нижних мочевых

путей, связанных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, при наличии симптомов наполнения.

Солифенацин – селективный конкурентный ингибитор мускариновых рецепторов мочевого пузыря, преимущественно M_3 – подтипа, имеет низкое или отсутствие сродства к другим рецепторам, ферментам и ионным каналам.

Тамсулозин – альфа $_1$ -адреноблокатор. Является селективным конкурентным блокатором постсинаптических α_1 – адренорецепторов, особенно α_{1A} и α_{1D} подтипов, отвечающих за расслабление гладкой мускулатуры нижних мочевых путей.

Фармакокинетика

Солифенацин

После многократного приема T_{max} для солифенацина варьировало между 4.27 ч и 4.76 ч в разных исследованиях, для тамсулозина – между 3.47 ч и 5.65 ч соответственно. C_{max} в плазме для солифенацина варьировала между 26.5 нг/мл и 32.0 нг/мл, для тамсулозина – между 6.56 нг/мл и 13.3 нг/мл. Значение AUC для солифенацина варьировало от 528 нг×ч/мл до 601 нг×ч/мл, для тамсулозина – между 97.1 нг×ч/мл и 222 нг×ч/мл. Абсолютная биодоступность для солифенацина составляет около 90%, в то время как тамсулозина абсорбируется на 70-79%.

После однократного приема $T_{1/2}$ для солифенацина варьирует от 49.5 ч до 53 ч, для тамсулозина – от 12.8 ч до 14 ч.

C_{max} достигается через 3-8 ч. T_{max} не зависит от дозы. C_{max} и AUC увеличиваются пропорционально повышению дозы от 5 до 40 мг. Абсолютная биодоступность – 90%. V_d солифенацина после в/в введения составляет примерно 600 л. Солифенацин в значительной степени (около 98%) связан с белками плазмы, преимущественно с α_1 -кислым гликопротеином.

Солифенацин активно метаболизируется в печени, преимущественно изоферментом CYP3A4. Однако существуют альтернативные метаболические пути, посредством которых может осуществляться метаболизм солифенацина. Системный клиренс солифенацина составляет около 9.5 л/ч, а конечный $T_{1/2}$ равен 45-68 ч. После приема препарата внутрь в плазме мимо солифенацина были идентифицированы следующие метаболиты: один фармакологически активный (4R-гидроксисолифенацин) и три неактивных N-глюкуронид, N-оксид и 4R-гидрокси-N-оксид солифенацина).

После однократного введения 10 мг ^{14}C -меченого солифенацина спустя 26 дней около 70% радиоактивности было обнаружено в моче и 23% в кале. В моче примерно 11% радиоактивности обнаружено в виде неизмененного активного вещества, около 18% в виде N-оксидного метаболита, 9% в виде 4R-гидрокси-N-оксидного метаболита и 8% в виде 4R-гидрокси метаболита (активный метаболит).

Тамсулозин

Тамсулозин характеризуется линейной фармакокинетикой. В равновесном состоянии C_{max} тамсулозина в плазме достигается через 4-6 ч. Связывание с белками плазмы – около 99%, V_d небольшой (около 0.2 л/кг).

Тамсулозин медленно метаболизируется в печени с образованием менее активных метаболитов. Большая часть тамсулозина представлена в плазме крови в неизмененном виде. Тамсулозин в основном метаболизируется в печени, преимущественно с участием изоферментов CYP3A4 и CYP2D6.

После однократного приема 0.2 мг ^{14}C -меченого тамсулозина через 1 неделю около 76% радиоактивности было выявлено в моче и 21% в кале. В моче около 9% радиоактивности было обнаружено в виде неизмененного активного вещества; около 16% в виде сульфата о-диэтилированного тамсулозина, и 8% в виде о-этоксифеноксисукусной кислоты.

В исследованиях клинической фармакологии и биодоступности возраст пациентов варьировал от 19 до 79 лет. После применения самые высокие показатели концентрации были выявлены у пожилых пациентов, хотя наблюдалось почти полное совпадение с отдельными показателями у более молодых пациентов. Можно применять у пожилых пациентов.

AUC и $C_{\max}$ солифенацина у пациентов с легкой и умеренной почечной недостаточностью незначительно отличаются от соответствующих показателей у здоровых добровольцев. У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью ($КК \leq 30$ мл/мин) экспозиция солифенацина значительно выше – увеличение $C_{\max}$ составляет около 30%, AUC – более 100% и $T_{1/2}$ – более 60%. Отмечена статистически значимая взаимосвязь между $КК$ и клиренсом солифенацина.

Показания к применению

Лекарственный препарат показан к применению у взрослых:

- для лечения от умеренных до тяжелых симптомов наполнения (острый позыв к мочеиспусканию, повышенная частота мочеиспускания) и симптомов мочеиспускания, связанных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) у мужчин, которые не реагируют надлежащим образом на лечение монотерапией.

Рекомендации по применению

Режим дозирования

Взрослые мужчины, включая пожилых

Одна таблетка Сенурикс Дуо (6 мг/0,4 мг) принимается один раз в день перорально, независимо от приема пищи. Максимальная суточная доза — одна таблетка Сенурикс Дуо (6 мг/0,4 мг).

Метод и путь введения

Для приема внутрь. Таблетку необходимо проглотить целиком, не раскусывая, не разжевывая и не раздавливая.

Длительность лечения

Длительность лечения определяется лечащим врачом.

Противопоказания

-пациенты с гиперчувствительностью к действующему (-ым) веществу (-ам) или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1

-пациенты, получающие гемодиализ

-пациенты с тяжелой печеночной недостаточностью

-пациенты с тяжелой формой почечной недостаточности, которые также принимают сильный ингибитор цитохрома P450 (CYP) 3A4, например, кетоконазол

-пациенты с умеренной формой нарушения функции печени, которые также принимают сильный ингибитор CYP3A4, например, кетоконазол

-пациенты с тяжелыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта (включая токсический мегаколон), миастенией гравис или узкоугольной глаукомой, а также пациенты с риском развития указанных заболеваний.

-пациенты с ортостатической гипотензией в анамнезе.

Необходимые меры предосторожности при применении

Пациенты с печеночной недостаточностью: влияние нарушения функции печени на действие Сенурикс Дуо не изучали. Однако влияние каждого отдельного активного вещества хорошо известно. При легкой степени нарушения функции печени, препарат Сенурикс Дуо принимать можно. При умеренно выраженных нарушениях функции печени, препарат необходимо принимать с осторожностью, максимальная суточная доза в таких случаях - одна таблетка Сенурикс Дуо (6 мг/0,4 мг). Препарат Сенурикс Дуо противопоказан при тяжелом нарушении функции печени.

Пациенты с почечной недостаточностью: влияние нарушения функции почек на действие Сенурикс Дуо не изучали. Однако влияние каждого отдельного активного вещества хорошо известно. При легком или умеренно выраженном нарушении функции почек Сенурикс Дуо принимать можно. При тяжелой форме нарушения функции почек,

препарат необходимо принимать с осторожностью, максимальная суточная доза для этих пациентов - одна таблетка Селурикс Дуо.

Одновременное применение с некоторыми лекарственными препаратами:

с осторожностью следует принимать Селурикс Дуо одновременно с такими препаратами, как верапамил, кетоконазол, ритонавир, нелфинавир, итраконазол. В таких случаях максимальная суточная доза Селурикс Дуо (6 мг/0,4 мг) - 1 таблетка.

Описание нежелательных реакций, которые проявляются при стандартном применении ЛП и меры, которые следует принять в этом случае

Солифенацин сукцинат/тамсулозин гидрохлорид

Часто

- головокружение, утомляемость
- нечеткость зрения
- сухость во рту, диспепсия, запор
- нарушения эякуляции, включая ретроградную эякуляцию и расстройство эякуляции.

Нечасто

- зуд
- задержка мочеиспускания.

Солифенацин 5 мг и 10 мг

Очень часто

- сухость во рту.

Часто

- нечеткость зрения
- диспепсия, запор, тошнота, боли в животе.

Нечасто

- инфекция мочевыводящих путей, цистит, затрудненное мочеиспускание
- сонливость, дисгевзия, утомляемость, периферический отек
- сухость глаз, сухость слизистой носа, сухость кожи
- гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, сухость в горле.

Редко

- головокружение, головная боль
- рвота, кишечная непроходимость, фекалома, задержка мочеиспускания
- зуд, сыпь.

Очень редко

- галлюцинации, спутанное сознание
- крапивница, ангионевротический отек, многоформная эритема.

Неизвестно (невозможно оценить на основании имеющихся данных)

- анафилактическая реакция, эксфолиативный дерматит
- снижение аппетита, гиперкалиемия
- бред, мышечная слабость
- глаукома
- ощущение сердцебиения, желудочковая тахикардия типа «пируэт», удлинение интервала QT на электрокардиограмме, мерцательная аритмия, тахикардия
- дисфония
- илеус, дискомфорт в животе, заболевания печени, нарушение функции печени
- почечная недостаточность

Тамсулозин 0,4 мг

Часто

- головокружение
- нарушения эякуляции, включая ретроградную эякуляцию и расстройство эякуляции.

Нечасто

- головная боль, ощущение сердцебиения, ортостатическая гипотензия, астения, ринит
- запор, тошнота, диарея, рвота

- зуд, сыпь, крапивница.

Редко

- обморочное состояние
- ангионевротический отек.

Очень редко

- синдром Стивенса-Джонсона
- приапизм.

Неизвестно (невозможно оценить на основании имеющихся данных)

- нечеткость зрения, интраоперационный синдром дряблой радужки, нарушения зрения
- мерцательная аритмия, аритмия, тахикардия
- одышка, носовое кровотечение
- многоформная эритема, эксфолиативный дерматит.

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами

Одновременный прием любых лекарственных препаратов с антихолинэргическими свойствами может привести к более выраженному терапевтическому действию и нежелательным эффектам. После прекращения лечения препаратом Селурикс Дуо, необходимо подождать примерно одну неделю, прежде чем начинать лечение любым антихолинэргическим препаратом. Терапевтический эффект солифенацина может быть уменьшен при одновременном применении агонистов холинэргических рецепторов.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Так как одновременное применение с такими препаратами как, кетоконазол, ритонавир, нелфинавир и итраконазол, может привести к усилению воздействия как солифенацина, так и тамсулозина, в случае назначения такой комбинации, Селурикс Дуо необходимо с осторожностью.

При одновременном применении Селурикс Дуо с верапамилом, возможно усиление действия тамсулозина, поэтому необходима осторожность при применении такой комбинации.

Одновременное применение тамсулозина с циметидином не вызывало усиления действия тамсулозина, поэтому допускается одновременный прием Селурикс Дуо в данной комбинации.

Одновременное применение тамсулозина с пароксетином не вызывало усиления действия тамсулозина, поэтому допускается одновременный прием Селурикс Дуо в данной комбинации.

Возможны лекарственные взаимодействия с другими препаратами (например, рифампицином), которые могут снижать в плазме концентрацию (ослаблять действие) солифенацина и тамсулозина.

Другие виды взаимодействия

Солифенацин

- Солифенацин может снижать действие лекарственных препаратов, которые стимулируют моторику желудочно-кишечного тракта, таких как метоклопрамид и цизаприд.

- Исследования солифенацина в условиях *in-vitro* показали, что при терапевтических концентрациях солифенацин не ингибирует CYP1A1/2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 или 3A4. Следовательно, между солифенацином и лекарственными препаратами, метаболизируемыми этими ферментами CYP, не ожидается никаких взаимодействий.

- Прием солифенацина не изменял действие R-варфарина или S-варфарина или их влияние на протромбиновое время.

- Прием солифенацина не оказывал влияния на действие дигоксина.

Тамсулозин

- Одновременное назначение других α_1 -адреноблокаторов может привести к выраженному снижению артериального давления.

- Исследования показали отсутствие влияния на действие тамсулозина при применении диазепама, пропранолола, трихлорметиазида, хлормадинона, амитриптилина, диклофенака, глибенкламида, симвастатина или варфарина. Тамсулозин не влияет на действие диазепама, пропранолола, трихлорметиазида или хлормадинона. Однако диклофенак и варфарин могут увеличивать скорость выведения тамсулозина.
- Одновременный прием фуросемида приводит к снижению уровня тамсулозина в плазме, но поскольку уровень остается в пределах нормального диапазона, одновременное применение допустимо.
- Исследования тамсулозина в условиях *in-vitro* показали, что при терапевтических концентрациях тамсулозин не ингибирует CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 или 3A4. Следовательно, не ожидается никаких взаимодействий между тамсулозином и лекарственными препаратами, метаболизируемыми этими ферментами CYP.
- При одновременном применении тамсулозина вместе с ателололом, эналаприлом или теofilлином взаимодействий не отмечалось.

Специальные предупреждения

Сенурикс Дуо следует с осторожностью применять при лечении пациентов со следующими расстройствами:

- почечная недостаточность;
- риск развития задержки мочеиспускания;
- заболевания с нарушением проходимости желудочно-кишечного тракта;
- риск снижения моторики желудочно-кишечного тракта;
- грыжа пищеводного отверстия диафрагмы/гастроэзофагеальный рефлюкс и (или) при одновременном применении таких лекарственных средств, как бисфосфонаты, которые могут вызывать или обострять эзофагит;
- вегетативная невропатия.

Пациента необходимо обследовать, чтобы исключить наличие других заболеваний, которые могут вызывать симптомы, аналогичные симптомам доброкачественной гиперплазии простаты.

До начала лечения препаратом Сенурикс Дуо необходимо выявить возможные другие причины частого мочеиспускания (сердечная недостаточность или заболевание почек). При наличии воспалительных заболеваний мочевыводящих путей, необходимо начать соответствующую антибактериальную терапию. У пациентов с такими факторами риска, как уже имеющийся синдром удлинения интервала QT и снижение уровня калия в крови, в период лечения наблюдалось удлинение интервала QT и желудочковая тахикардия типа «пируэт».

У некоторых пациентов, принимающих солифенацина сукцинат и тамсулозин, сообщалось о развитии ангионевротического отека с нарушением проходимости дыхательных путей. При развитии ангионевротического отека необходимо прекратить прием Сенурикс Дуо и больше его не возобновлять. Следует провести соответствующую терапию и (или) принять надлежащие меры.

При лечении тамсулозином, как и при применении других α_1 -адреноблокаторов в отдельных случаях может наблюдаться снижение артериального давления, которое иногда способно приводить к обморочному состоянию. Пациентов, начинающих лечение препаратом Сенурикс Дуо, следует предупредить о том, что при первых признаках выраженного снижения артериального давления при принятии вертикального положения (головокружение, слабость) необходимо сесть или лечь и не вставать, пока симптомы не исчезнут.

У некоторых пациентов, принимающих или ранее принимавших тамсулозина гидрохлорид, во время оперативного вмешательства по поводу катаракты и глаукомы отмечалось развитие интраоперационного синдрома дряблой радужки (вариант синдрома узкого зрачка). Во время операции или в послеоперационном периоде, интраоперационный синдром дряблой радужки может повысить риск осложнений со

стороны глаз, поэтому не рекомендуется начинать терапию Сенурикс Дуо у пациентов, которым запланировано оперативное лечение катаракты или глаукомы. По некоторым данным, считается полезным отмена терапии Сенурикс Дуо за 1–2 недели до операции по поводу катаракты или глаукомы, но окончательная польза от отмены терапии не установлена. Во время предоперационного обследования пациентов, хирург и врач-офтальмолог должны учитывать, принимает или принимал ли пациент, которому запланирована операция по поводу катаракты или глаукомы, Сенурикс Дуо, чтобы обеспечить необходимые меры контроля возможного развития во время операции интраоперационного синдрома дряблой радужки.

Из-за возможных лекарственных взаимодействий, Сенурикс Дуо не следует применять в комбинации с такими препаратами, как кетоконазол или пароксетин.

Применение в педиатрии

Препарат Сенурикс Дуо не применяется для лечения детей и подростков.

Во время беременности или лактации

Беременность

Результаты исследований солифенацина или тамсулозина на животных не указывают на вредное воздействие на возможность развития беременности и раннее эмбриональное развитие плода.

В краткосрочных и длительных клинических исследованиях с тамсулозином наблюдались нарушения эякуляции. Сообщалось о случаях нарушения эякуляции, ретроградной эякуляции и нарушения эякуляции в пострегистрационном периоде. Сенурикс Дуо не показан для применения у женщин.

Фертильность

Влияние Сенурикс Дуо на способность иметь детей не установлено.

Особенности влияния препарата на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Исследования влияния Сенурикс Дуо на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами не проводились, но пациентов необходимо проинформировать о возможном развитии головокружения, нечеткости зрения, усталости и в редких случаях, сонливости, что может негативно повлиять на способность управлять транспортным средством или при использовании механизмов.

Меры, которые необходимо принять в случае передозировки

Симптомы: передозировка при комбинированном приеме солифенацина и тамсулозина может привести к тяжелым антихолинергическим эффектам и выраженному снижению кровяного давления. Самая высокая доза, случайно принятая во время клинического исследования, составляла 126 мг солифенацина сукцината и 5,6 мг тамсулозина гидрохлорида. Пациент хорошо перенес эту дозу, отмечалась лишь небольшая сухость во рту в течение 16 дней.

Лечение: в случае передозировки солифенацином и тамсулозином пациенту следует назначить лечение активированным углем. Промывание желудка помогает, если выполнить его в течение 1 часа после передозировки, но рвоту вызывать не следует.

Что касается других антихолинергических средств, симптомы передозировки, вызванные компонентом солифенацином, можно лечить следующим образом:

- Серьезные центральные антихолинергические эффекты, такие как галлюцинации или выраженное возбуждение можно лечить физостигмином или карбахолом.
- Судороги или выраженное возбуждение: лечение бензодиазепинами.
- Дыхательная недостаточность: искусственная вентиляция легких.
- Тахикардия: при необходимости, симптоматическое лечение. Бета-блокаторы следует применять с осторожностью, так как одновременная передозировка тамсулозином может вызвать тяжелую форму снижения кровяного давления.
- Задержка мочеиспускания: лечение катетеризацией.

Как и в случае с другими антимускариновыми средствами, в случае передозировки особое внимание следует уделять пациентам с известным риском удлинения интервала QT (например, гипокалиемией, брадикардией) и пациентам, одновременно принимающим лекарственные препараты, удлиняющие интервал QT, а также пациентам с уже заболеваниями сердца (например, ишемией миокарда, аритмией, застойной сердечной недостаточностью).

При остром снижении кровяного давления, которое может развиваться после передозировки из-за тамсулозина, назначается симптоматическое лечение. Из-за высокой степени связывания тамсулозина с белками плазмы польза от гемодиализа маловероятна.

Форма выпуска и упаковка

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из фольги алюминиевой oPA-Al-PVC.

По 3 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Срок хранения

3 года. Не применять по истечении срока годности!

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C

Хранить в недоступном для детей месте!

Условия отпуска из аптек

По рецепту

Производитель

SYNTHON HISPANIA S.L.

к/Кастельо, 1 САНТ БОЙ ДЕ ЛЬОБРЕГАТ (Барселона),

08830, Испания

Владелец регистрационного удостоверения:

Vegapharm LLP

Unit 18, 53 Norman Road, Greenwich Centre Business Park,

London, England, SE10 9QF, Великобритания

Адрес организации, принимающей на территории Кыргызской Республики претензии от потребителей по качеству продукта:

ОсОО «Аман Фарм» г. Бишкек, Республика Кыргызстан, ул. Тыныстанова дом 4а, кв. 11,

E-mail: aman.pharm_12@gmail.com